

CẨM NANG PRO

DẤU HIỆU NHỒI MÁU CƠ TIM

Nhận biết sớm - Gọi cấp cứu đúng - Giảm chậm trễ nguy hiểm

THÔNG ĐIỆP CẦN NHỚ

Đau hoặc khó chịu ở ngực, khó thở, vã mồ hôi lạnh, buồn nôn, choáng hoặc đau lan lên tay - hàm - lưng có thể là dấu hiệu cảnh báo. Không chờ triệu chứng tự hết. Hãy gọi 115 ngay khi nghi ngờ.

Tài liệu dành cho cộng đồng, đặc biệt người từ 40 tuổi trở lên và người có nguy cơ tim mạch.

TIM KHỎE MỖI NGÀY™

Phiên bản PRO - 2026

1. Cách sử dụng cẩm nang

Mục tiêu của tài liệu là giúp người đọc nhận ra các dấu hiệu thường gặp và không điển hình của nhồi máu cơ tim, phản ứng đúng trong những phút đầu và giảm các sai lầm làm chậm cấp cứu.

BA VIỆC QUAN TRỌNG NHẤT

1. Nhận biết dấu hiệu cảnh báo.
2. Gọi 115 và làm theo hướng dẫn của nhân viên cấp cứu.
3. Không tự lái xe, không chờ đợi và không tự dùng thuốc tùy tiện.

Ai nên đọc kỹ?

- Người từ 40 tuổi trở lên.
- Người tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn mỡ máu, thừa cân hoặc hút thuốc.
- Người đã từng đau thắt ngực, đặt stent, phẫu thuật cầu nối hoặc có bệnh tim mạch.
- Thành viên gia đình, đồng nghiệp và người chăm sóc người cao tuổi.

LƯU Ý

Không phải mọi cơn đau ngực đều là nhồi máu cơ tim, nhưng không thể loại trừ nhồi máu cơ tim chỉ bằng cảm giác, vị trí đau hoặc việc triệu chứng có giảm khi nghỉ. Chẩn đoán cần đánh giá y tế, điện tâm đồ và xét nghiệm phù hợp.

2. Nhồi máu cơ tim là gì?

Nhồi máu cơ tim xảy ra khi dòng máu đến một vùng cơ tim bị giảm nghiêm trọng hoặc tắc nghẽn, thường do cục máu đông hình thành trên mảng xơ vữa trong động mạch vành. Cơ tim thiếu oxy sẽ bị tổn thương; thời gian chậm trễ càng lâu, vùng cơ tim có nguy cơ tổn thương càng lớn.

“THỜI GIAN LÀ CƠ TIM”

Mục tiêu của cấp cứu là đưa người bệnh đến hệ thống y tế có khả năng đánh giá và tái thông mạch càng sớm càng tốt. Đừng cố tự chẩn đoán tại nhà.

Nhồi máu cơ tim khác ngừng tim

Nhồi máu cơ tim	Ngừng tim
Vấn đề tuần hoàn: một động mạch vành bị tắc hoặc giảm dòng máu. Người bệnh thường còn tỉnh và còn thở lúc khởi phát.	Vấn đề điện học: tim đột ngột ngừng bơm hiệu quả. Người bệnh mất đáp ứng, không thở bình thường hoặc chỉ thở ngáp.
Có thể dẫn đến ngừng tim. Cần gọi 115 ngay.	Gọi 115, bắt đầu ép tim nếu được hướng dẫn và dùng AED nếu có.

3. Dấu hiệu điển hình thường gặp

Triệu chứng có thể khởi phát đột ngột hoặc tăng dần. Có người chỉ khó chịu nhẹ; có người đau dữ dội. Các dấu hiệu có thể xuất hiện đơn độc hoặc phối hợp.

1) Khó chịu hoặc đau vùng ngực

- Vị trí thường ở giữa ngực hoặc lệch trái.
- Cảm giác đè nặng, bóp nghẹt, siết chặt, đầy tức, nóng rát hoặc đau.
- Kéo dài hơn vài phút, hoặc giảm rồi tái phát.
- Không nên chỉ dựa vào mức độ đau: nhồi máu cơ tim có thể không đau dữ dội.

2) Đau hoặc khó chịu lan ra vùng khác

- Một hoặc hai cánh tay, đặc biệt vai và tay trái.
- Lưng, cổ, hàm hoặc vùng thượng vị.
- Cảm giác có thể giống đau cơ, đau răng, đau vai gáy hoặc khó tiêu.

3) Khó thở

Có thể xuất hiện cùng đau ngực hoặc không có đau ngực. Người bệnh có thể thấy hụt hơi khi đang nghỉ hoặc chỉ hoạt động rất nhẹ.

NGUYÊN TẮC AN TOÀN

Khi một triệu chứng mới xuất hiện, khác thường, kéo dài hoặc đi kèm vã mồ hôi lạnh, choáng, buồn nôn hay khó thở: hãy coi đó là tình huống cấp cứu cho đến khi nhân viên y tế đánh giá.

4. Các dấu hiệu đi kèm dễ bị bỏ qua

Vã mồ hôi lạnh

Toát mồ hôi không giải thích được, da lạnh hoặc ẩm, nhất là khi kèm đau ngực hoặc buồn nôn.

Buồn nôn hoặc nôn

Có thể bị nhầm với rối loạn tiêu hóa, ngộ độc thức ăn hoặc trào ngược.

Choáng, yếu, gần ngất

Cảm giác lâng lâng, mất thăng bằng, yếu đột ngột hoặc sắp ngất.

Mệt bất thường

Kiệt sức không tương xứng với hoạt động; ở một số người có thể xuất hiện trước nhiều giờ hoặc nhiều ngày.

Bồn chồn hoặc cảm giác nguy hiểm

Một số người mô tả lo lắng bất thường hoặc cảm giác “có chuyện không ổn”.

Không dùng một dấu hiệu đơn lẻ để tự loại trừ bệnh. Sự phối hợp triệu chứng, bối cảnh và yếu tố nguy cơ quan trọng hơn.

5. Triệu chứng không điển hình ở một số nhóm

Người cao tuổi, phụ nữ và người đái tháo đường có thể biểu hiện ít điển hình hơn. Tuy vậy, đau hoặc khó chịu ngực vẫn là triệu chứng phổ biến ở cả nam và nữ.

Phụ nữ

- Có thể nổi bật bởi khó thở, buồn nôn, đau lưng hoặc vai, choáng và mệt bất thường.
- Không nên coi triệu chứng “không giống đau tim trong phim” là an toàn.

Người cao tuổi

- Có thể chỉ khó thở, lơ mơ, yếu, ngất hoặc giảm khả năng hoạt động.
- Đau ngực có thể nhẹ hoặc không rõ.

Người đái tháo đường

- Tổn thương thần kinh tự chủ có thể làm cảm giác đau kém điển hình.
- Khó thở, vã mồ hôi, mệt hoặc khó chịu vùng thượng vị có thể là biểu hiện chính.

ĐỪNG CHỜ “ĐỦ TRIỆU CHỨNG”

Chỉ cần nghi ngờ hợp lý, đặc biệt ở người có nguy cơ cao, hãy gọi 115. Nhồi máu cơ tim có thể xảy ra mà không có đau ngực rõ rệt.

6. Nhận diện kiểu khởi phát nguy hiểm

Nhồi máu cơ tim không có một “kịch bản” cố định. Hãy chú ý đến tính mới, kéo dài, tái diễn và sự phối hợp triệu chứng.

Bốn kiểu cần cảnh giác

Đột ngột

Đang nghỉ hoặc hoạt động thì xuất hiện đau ngực, khó thở, vã mồ hôi hoặc choáng.

Tăng dần

Khó chịu ban đầu nhẹ nhưng tăng trong vài phút hoặc kèm thêm triệu chứng.

Đến rồi đi

Triệu chứng giảm tạm thời rồi tái phát; không có nghĩa là đã an toàn.

Không điển hình

Chỉ mệt, buồn nôn, đau lưng, đau hàm, khó tiêu hoặc khó thở.

QUY TẮC THỰC HÀNH

Triệu chứng kéo dài hơn vài phút, tái diễn, hoặc khiến người bệnh phải dừng hoạt động - đặc biệt kèm khó thở, lạnh toát, buồn nôn hay choáng - cần được xử trí như cấp cứu tim mạch.

7. Phân biệt tham khảo - không dùng để tự chẩn đoán

Các đặc điểm dưới đây chỉ giúp hiểu sự khác biệt thường gặp. Chúng không đủ để loại trừ nhồi máu cơ tim.

Đặc điểm	Nhồi máu cơ tim có thể	Nguyên nhân khác có thể
Cảm giác	Đè nặng, siết, đầy tức, nóng rát hoặc đau.	Đau nhói, nóng rát, đau khi ấn hoặc thay đổi tư thế cũng có thể gặp.
Vị trí	Giữa ngực; lan tay, vai, lưng, cổ, hàm, thượng vị.	Có thể khu trú một điểm hoặc liên quan bữa ăn, vận động cơ.
Đi kèm	Khó thở, vã mồ hôi lạnh, buồn nôn, yếu, choáng.	Ợ chua, đau khi hít sâu, đau khi ấn hoặc xoay người.
Ý nghĩa	Cần đánh giá cấp cứu ngay khi nghi ngờ.	Vẫn có thể cần khám; không tự kết luận chỉ vì đau giống dạ dày hay cơ xương.

ĐIỂM MẤU CHÓT

Trào ngược, đau cơ và lo âu có thể gây đau ngực, nhưng nhồi máu cơ tim cũng có thể giống khó tiêu, đau vai gáy hoặc hoảng sợ. Khi không chắc chắn, lựa chọn an toàn là gọi cấp cứu.

8. Khi nào phải gọi 115 ngay?

GỌI NGAY - KHÔNG CHỜ

Đau hoặc khó chịu ngực kéo dài hơn vài phút hoặc tái phát; khó thở; đau lan tay, vai, lưng, cổ, hàm hoặc thượng vị; vã mồ hôi lạnh; buồn nôn; yếu, choáng hoặc ngất.

Gọi 115 càng sớm càng quan trọng khi:

- Người bệnh có tiền sử bệnh mạch vành, nhồi máu cơ tim, đặt stent hoặc đau thắt ngực.
- Có tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn mỡ máu, hút thuốc hoặc bệnh thận.
- Triệu chứng xuất hiện khi nghỉ, đánh thức ban đêm hoặc khác rõ với những lần khó chịu trước.
- Người bệnh tái nhợt, lạnh, thở khó, lơ mơ hoặc sắp ngất.

VÌ SAO KHÔNG NÊN TỰ LÁI XE?

Tình trạng có thể xấu đi đột ngột, gây rối loạn nhịp hoặc ngừng tim. Nhân viên cấp cứu có thể bắt đầu đánh giá và hỗ trợ trên đường đến bệnh viện; đồng thời giúp chọn nơi tiếp nhận phù hợp.

9. Xử trí trong những phút đầu

1

Gọi 115

Nói rõ địa chỉ, số điện thoại, triệu chứng, thời điểm bắt đầu và bệnh nền quan trọng.

2

Cho người bệnh nghỉ

Ngồi hoặc nằm ở tư thế dễ thở; nói lỏng quần áo chật; hạn chế đi lại.

3

Theo dõi

Quan sát mức tỉnh táo và nhịp thở; chuẩn bị danh sách thuốc, dị ứng và hồ sơ bệnh.

4

Mở lối đón cấp cứu

Cử người chờ, mở cửa hoặc hướng dẫn đường; không để người bệnh ở một mình.

5

Làm theo tổng đài

Chỉ dùng thuốc khi nhân viên y tế hướng dẫn hoặc thuốc đã được bác sĩ kê cho đúng tình huống.

VỀ ASPIRIN

Không tự động cho mọi người dùng aspirin. Aspirin có thể không phù hợp khi dị ứng, đang chảy máu, dùng thuốc chống đông hoặc có bệnh lý khác. Hãy làm theo hướng dẫn của tổng đài cấp cứu hoặc nhân viên y tế.

10. Nếu người bệnh bất tỉnh hoặc không thở bình thường

NGHI NGỜ NGỪNG TIM

Người bệnh không đáp ứng và không thở bình thường hoặc chỉ thở ngáp: gọi 115 ngay, bật loa ngoài và bắt đầu hồi sinh tim phổi theo hướng dẫn.

Các bước cơ bản

- Đặt người bệnh nằm ngửa trên bề mặt cứng, an toàn.
- Ép mạnh và nhanh ở giữa ngực nếu tổng đài hướng dẫn; giảm tối đa việc ngừng ép.
- Nhờ người khác tìm máy khử rung tim tự động (AED) nếu nơi đó có trang bị.
- Bật AED và làm đúng hướng dẫn bằng giọng nói của thiết bị.
- Tiếp tục cho đến khi người bệnh có dấu hiệu sống hoặc nhân viên cấp cứu tiếp nhận.

KHÔNG SỢ “LÀM SAI”

Ở người mất đáp ứng và không thở bình thường, hành động sớm tốt hơn chờ đợi. Tổng đài 115 có thể hướng dẫn từng bước.

Ghi nhớ: nhồi máu cơ tim là một nguyên nhân có thể dẫn đến ngừng tim. Vì vậy việc nhận biết và gọi cấp cứu sớm có thể ngăn tình trạng diễn tiến đến giai đoạn nguy kịch.

11. Những việc không nên làm

Không chờ xem có tự hết không

Triệu chứng có thể giảm rồi quay lại; trì hoãn làm mất thời gian điều trị.

Không tự lái xe

Có nguy cơ ngất, rối loạn nhịp hoặc ngừng tim trên đường.

Không để người bệnh đi lại

Hoạt động làm tăng nhu cầu oxy của tim.

Không xoa bóp, cạo gió hoặc bấm huyệt thay cấp cứu

Những cách này không tái thông động mạch vành.

Không tự dùng thuốc giảm đau hoặc thuốc dạ dày để “thử”

Giảm triệu chứng không loại trừ nhồi máu cơ tim.

Không tự dùng thuốc của người khác

Nitroglycerin, aspirin và các thuốc tim mạch có chống chỉ định, tương tác và nguy cơ.

Không cho ăn uống nhiều

Có thể gây nôn hoặc ảnh hưởng xử trí y tế.

12. Ai có nguy cơ cao hơn?

Nhồi máu cơ tim có thể xảy ra ở bất kỳ ai, kể cả người chưa từng được chẩn đoán bệnh tim. Nguy cơ tăng khi có nhiều yếu tố phối hợp.

Yếu tố có thể thay đổi

- Hút thuốc lá hoặc thường xuyên hít khói thuốc.
- Tăng huyết áp.
- Cholesterol máu cao.
- Đái tháo đường.
- Thừa cân, béo phì hoặc vòng eo lớn.
- Ít vận động.
- Chế độ ăn nhiều muối, chất béo bão hòa và thực phẩm siêu chế biến.
- Ngủ kém kéo dài, stress và sử dụng rượu không an toàn.

Yếu tố khó thay đổi

- Tuổi tăng.
- Tiền sử gia đình mắc bệnh tim mạch sớm.
- Đã có bệnh mạch vành, đột quỵ hoặc bệnh động mạch ngoại biên.

QUAN TRỌNG

Không có yếu tố nguy cơ rõ không đồng nghĩa với không thể bị nhồi máu cơ tim. Khi có dấu hiệu cảnh báo, xử trí dựa trên triệu chứng chứ không chờ “đủ nguy cơ”.

13. Bảng tự đánh giá nguy cơ tim mạch

Đánh dấu các mục phù hợp và mang bảng này khi khám định kỳ. Đây không phải công cụ chẩn đoán hoặc tính điểm nguy cơ chính thức.

STT	Nội dung	Có	Không
1	Tôi đang hút thuốc hoặc mới bỏ thuốc.	☐	☐
2	Tôi đã được chẩn đoán tăng huyết áp.	☐	☐
3	Tôi có đái tháo đường hoặc đường huyết cao.	☐	☐
4	Tôi có cholesterol hoặc triglyceride cao.	☐	☐
5	Tôi ít vận động trong tuần.	☐	☐
6	Tôi thừa cân hoặc vòng eo tăng.	☐	☐
7	Gia đình có người mắc bệnh tim mạch sớm.	☐	☐
8	Tôi từng đau ngực, khó thở khi gắng sức hoặc đã có bệnh mạch vành.	☐	☐
9	Tôi có bệnh thận mạn.	☐	☐
10	Tôi thường xuyên ngủ kém hoặc ngáy to/ngưng thở khi ngủ.	☐	☐

Trao đổi với bác sĩ về huyết áp, đường huyết, mỡ máu và kế hoạch giảm nguy cơ phù hợp với tuổi, bệnh nền và thuốc đang dùng.

14. Giảm nguy cơ nhồi máu cơ tim

Phòng ngừa không loại bỏ hoàn toàn nguy cơ, nhưng kiểm soát các yếu tố có thể thay đổi giúp bảo vệ tim mạch lâu dài.

Bỏ thuốc lá

Tìm hỗ trợ chuyên môn; tránh khói thuốc thụ động.

Kiểm soát huyết áp

Đo đúng cách, ghi lại kết quả và dùng thuốc theo đơn.

Quản lý đường huyết và mỡ máu

Khám định kỳ và không tự ngừng thuốc khi thấy khỏe.

Vận động đều

Hướng tới vận động aerobic mức vừa và tập sức mạnh phù hợp; tăng dần nếu trước đây ít vận động.

Ăn bảo vệ tim

Ưu tiên rau, trái cây nguyên quả, ngũ cốc nguyên hạt, đậu, cá và nguồn đạm ít béo; giảm muối, đường thêm, chất béo bão hòa.

Ngủ và quản lý stress

Duy trì giờ ngủ ổn định; trao đổi với bác sĩ nếu ngáy to hoặc buồn ngủ ban ngày.

Tái khám sau biến cố tim

Tuân thủ thuốc, phục hồi chức năng tim và nhận biết dấu hiệu tái phát.

15. Kế hoạch cấp cứu tim mạch cho gia đình

Chuẩn bị trước giúp gia đình phản ứng nhanh hơn khi căng thẳng.

Mục	Thông tin cần điền
Số cấp cứu	115
Địa chỉ đầy đủ	_____
Mốc dễ tìm	_____
Người liên hệ 1	_____ SĐT: _____
Người liên hệ 2	_____ SĐT: _____
Bệnh viện/đơn vị theo dõi	_____
Bệnh nền quan trọng	_____
Dị ứng thuốc	_____
Thuốc đang dùng	_____

NÊN CHUẨN BỊ

Danh sách thuốc và liều dùng; ảnh căn cước/bảo hiểm nếu phù hợp; hồ sơ bệnh tim; số điện thoại người thân; vị trí AED tại cơ quan hoặc chung cư nếu có.

Thực hành cùng gia đình: ai gọi 115, ai mở cửa đón cấp cứu, ai lấy hồ sơ và ai ở cạnh người bệnh.

16. Checklist 60 giây khi nghi ngờ

NHẬN BIẾT

- ☐ Khó chịu/đau ngực
- ☐ Khó thở
- ☐ Đau lan tay, vai, lưng, cổ, hàm hoặc thượng vị
- ☐ Vã mồ hôi lạnh
- ☐ Buồn nôn, yếu, choáng hoặc ngất

HÀNH ĐỘNG

- ☐ Gọi 115 ngay
- ☐ Cho người bệnh nghỉ, hạn chế đi lại
- ☐ Không tự lái xe
- ☐ Không tự dùng thuốc tùy tiện
- ☐ Chuẩn bị thông tin bệnh, thuốc và dị ứng
- ☐ Theo dõi đáp ứng và nhịp thở

NẾU BẤT TỈNH, KHÔNG THỞ BÌNH THƯỜNG

- ☐ Báo tổng đài 115
- ☐ Bật loa ngoài
- ☐ Bắt đầu ép tim theo hướng dẫn
- ☐ Dùng AED nếu có và làm theo thiết bị

Hãy chụp hoặc in trang này, đặt ở vị trí dễ thấy trong nhà hoặc cơ quan.

17. Nguồn tham khảo và lưu ý chuyên môn

Nội dung được tổng hợp và diễn giải cho mục đích giáo dục cộng đồng từ các nguồn chuyên môn chính thức. Truy cập ngày 17/07/2026.

Nguồn chính

- American Heart Association. Warning Signs of a Heart Attack; Heart Attack Symptoms in Women; Heart Attack Explained. Cập nhật/đánh giá 2024.
- Centers for Disease Control and Prevention. About Heart Attack Symptoms, Risk, and Recovery; About Heart Disease; Women and Heart Disease.
- National Heart, Lung, and Blood Institute (NIH). What Is a Heart Attack?; Heart Attack - Symptoms; Coronary Heart Disease - Symptoms.
- European Society of Cardiology. 2023 ESC Guidelines for the management of acute coronary syndromes; Acute coronary syndrome in elderly and frail patients.
- Các nguyên tắc hồi sinh tim phổi cộng đồng và sử dụng AED theo hướng dẫn của tổng đài cấp cứu và cơ quan y tế địa phương.

MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM

Tài liệu này không dùng để chẩn đoán, kê đơn hoặc thay thế tư vấn trực tiếp của bác sĩ. Trong tình huống nghi ngờ nhồi máu cơ tim tại Việt Nam, hãy gọi 115 hoặc số cấp cứu phù hợp tại nơi đang sinh sống.

Hãy lưu tài liệu, chia sẻ cho người thân và theo dõi Tim Khỏe Mỗi Ngày™ để cùng xây dựng kỹ năng nhận biết cấp cứu tim mạch.

TIM KHỎE MỖI NGÀY™